Escribas digitales

Qué son, por qué importan y cómo evaluar su encaje

De la consulta a una **nota clínica revisada**.

Para un hospital con atención en español y **Dedalus HCIS**.

10 minutos · 5 bloques

1. Qué es
2. Por qué importa
3. Mercado y encaje
4. Discusión: cómo evaluar
5. Conclusión y siguientes pasos

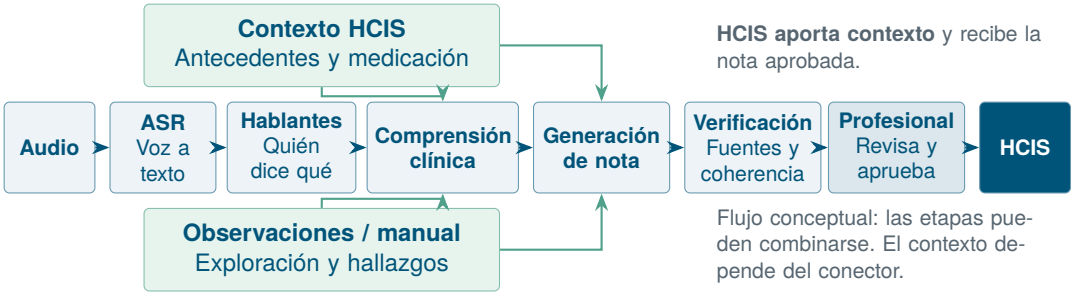
INSTITUTO RAMÓN Y CAJAL DE INVESTIGACIÓN SANITARIA IR-yCIS

Propuesta: comprobar calidad y utilidad local antes de elegir una solución.

Fuentes: Informe completo y guion del proyecto, 18/09/2026. Investigación adicional y comprobaciones selectivas: 07/10/2026. Revisión documental.

Una nota combina conversación y contexto

El escriba transforma información disponible en un borrador clínico estructurado.

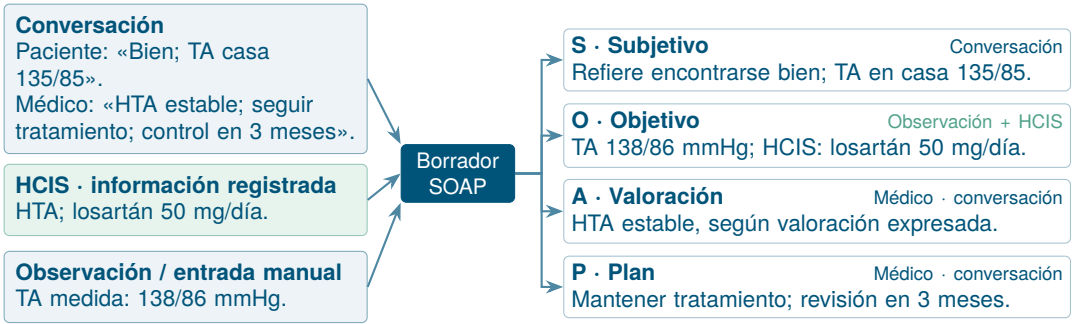


La verificación automática ayuda; el profesional confirma datos y resuelve discrepancias.

Fuentes: NHS England, v3, 2026; Nabla: transcripción y contexto; esquema conceptual del proyecto. ASR: reconocimiento automático del habla.

Ejemplo: de tres fuentes a una nota SOAP

Caso ficticio de seguimiento de hipertensión · cada dato conserva su origen.



Valoración y plan expresados por el médico; contexto de HCIS pendiente de confirmar.

Fuentes: Ejemplo propio, ilustrativo. SOAP: Subjetivo, Objetivo, Valoración (Assessment) y Plan. La ubicación de medicación puede variar según la plantilla.

El beneficio que buscamos: menos carga documental

Recuperar atención y tiempo a lo largo de la jornada.



Menos teclado

durante la consulta



Más atención

al paciente



Menos pendientes

al terminar

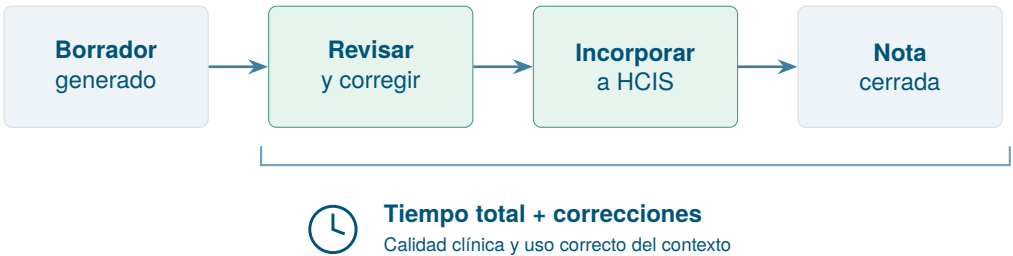
16 min menos de documentación por cada **8 horas de agenda**

Asociación observada en cinco centros de EE. UU. · JAMA, 2026

Fuentes: Rotenstein et al., JAMA, 2026: 8.581 clínicos, 1.809 con acceso a escriba. Estudio observacional; resultado variable, no ahorro por consulta ni garantía local. Los tres objetivos superiores son beneficios que evaluar.

Hay que medir hasta que la nota queda cerrada

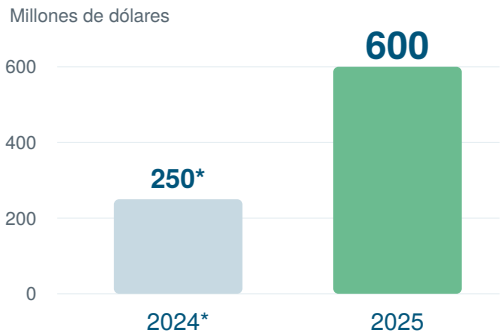
El ahorro depende del trabajo que sigue al borrador.



Fuentes: Propuesta local de evaluación. JAMA, 2026; Biro et al., 2025. La comparación con el flujo habitual debe incluir revisión, corrección y cierre.

El mercado de escribas crece con rapidez

Ingresos estimados de escribas ambientales · Menlo Ventures, 2025.



×2,4

en un año

La documentación es una de las primeras grandes categorías de IA clínica.

Fuentes: Menlo Ventures, The State of AI in Healthcare, 2025. Gráfico propio. *2024 derivado: 600/2,4; no estimación independiente. Informe centrado en EE. UU., encuesta a más de 700 directivos y estimaciones de ingresos; fuente inversora. No mide el mercado español.

Muchas ofertas; varias formas de llegar al hospital

Cuatro familias orientativas, que se solapan.

43

proveedores en nuestro inventario

Septiembre de 2026
Muestra documental

Uso individual

Heidi · Noa · Freed

Oferta hospitalaria

Tandem · Invox · Align

Ecosistemas HCE

Microsoft · Oracle · Abridge

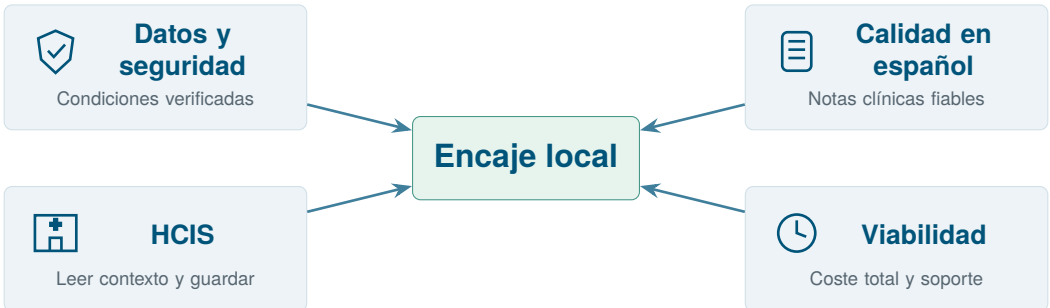
APIs y desarrollo

Corti · AWS · Quirónsalud

Fuentes: Inventario del informe: 09/09/2026 + AWS, 17/09. Familias propias para explicar vías de oferta, no cuotas ni categorías excluyentes. El recuento de 43 no es un censo del mercado.

El encaje que buscamos tiene cuatro piezas

Una buena demo debe convertirse en un flujo viable en nuestro hospital.



Fuentes: Requisitos propuestos en el informe del proyecto: datos, seguridad, calidad, integración y coste. HCIS exige comprobar paciente/episodio, lectura de contexto y devolución de la nota revisada.

Hay candidatos; el encaje sigue por demostrar

Selección corta del informe · principal incógnita visible: el flujo con HCIS.

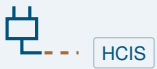
Tandem



HCIS no disponible

según su ficha pública

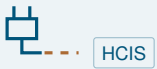
Invox Genesis



API disponible

conector HCIS por demostrar

Solventum Align



Integración HCE

HCIS específico por confirmar

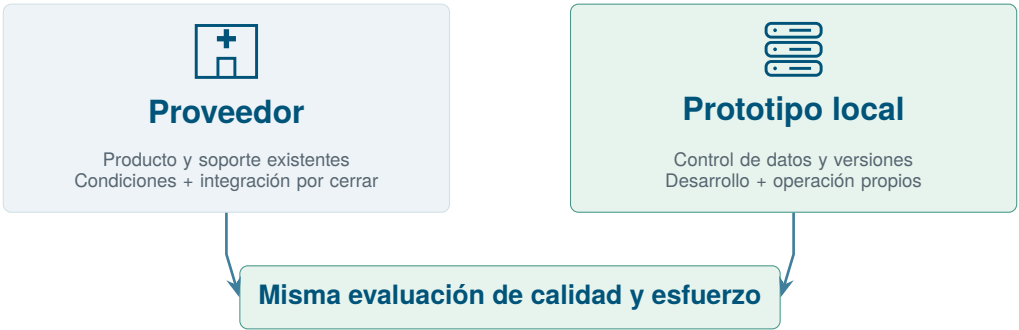
También por cerrar para esta selección

- Calidad clínica local
- Expediente de datos
- Coste total

Fuentes: Tandem HCIS; Invox API; Align. Revisión selectiva 09/10/2026; declaraciones comerciales, sin prueba funcional. Falta de evidencia local no implica imposibilidad técnica.

Dos vías que podemos poner a prueba

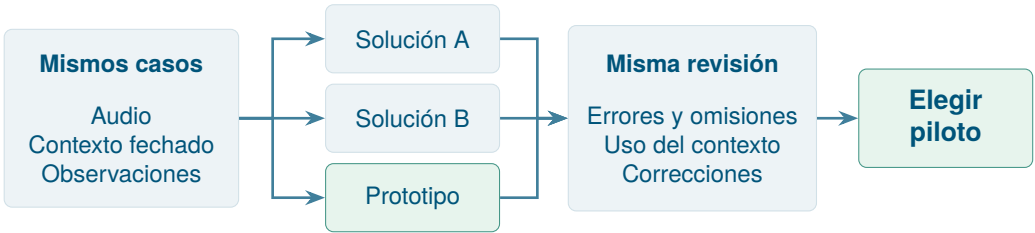
La vía local es una opción de exploración, sujeta a recursos.



Fuentes: Propuesta del proyecto. Referencias exploratorias: OpenScribe, Phlox; sin instalación ni validación local. Un prototipo local también necesita seguridad, mantenimiento e integración.

Los mismos casos permiten una comparación justa

El banco de casos sirve para decidir qué solución merece un piloto.

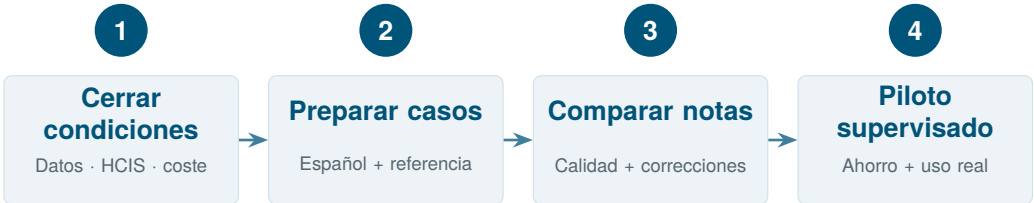


Pruebas repetibles por lotes + revisión clínica de muestras y casos señalados

Fuentes: Diseño propuesto, basado en Biro et al., 2025 y Zhou et al., 2025. Casos de ajuste separados de evaluación; revisión clínica. El ahorro real se comprueba después, en el piloto asistencial.

Siguiente paso: comparar antes de pilotar

Cada etapa deja un resultado que permite decidir la siguiente.



Decisión del siguiente hito: qué solución pilotar y con qué condiciones

Fuentes: Propuesta del proyecto: requisitos y criterios de éxito por acordar; candidatos y posible comparador local. El piloto procede si la comparación acredita calidad y viabilidad suficientes.

La decisión ahora: iniciar una evaluación local

La oportunidad está clara. El encaje debe demostrarse en nuestro flujo.

Elegir qué pilotar con evidencia propia.



Notas fiables



Menos trabajo



Integración HCIS

Para arrancar: un servicio · responsables clínico y técnico · recursos acotados

Fuentes: Conclusión y propuesta del proyecto. Próximo entregable: comparación de calidad, esfuerzo e integración para decidir el alcance del piloto.